

Microorganismo	Tipo de transmisión	Periodo de incubación	Cuadro clínico	Diagnostico	Fisiología	Tratamiento
Viral						
Rotavirus	Vía fecal-oral, alimentos contaminados y/o por contacto con superficies u objetos contaminados, brotes durante el invierno, guarderías asilos.	2 a 4 días.	Diarrea osmótica, Vómito, dolor abdominal, fiebre (mayor de 39°C), pérdida de apetito y deshidratación.	Análisis moleculares detectar antígenos específicos, anticuerpos o ácidos nucleicos en las heces de pacientes con infección.	En las puntas de las vellosidades, el epitelio columnar es reemplazado por células cuboidales irregulares. Pérdida de cap. De absorción.	Rehidratación oral o intravenosa, loperamida y subsalicilato de bismuto.
Norovirus		12 y 48 horas.	Diarrea osmótica, Fiebre (variable), dolor abdominal, náuseas y vomito.			
Astrovirus		1 a 2 días.	Diarrea abundante y acuosa, náuseas, vómito, fiebre, malestar, anorexia y dolor abdominal hasta por 2–3 días			

Adenovirus		1 a 2 días.	Diarrea acuosa, fiebre, sensibilidad abdominal, tos fuerte y vómitos			
Bacteriana						
Salmonella sp.	Transmisión fecal - oral, adquirida en la comunidad	12 a 36 horas.	Diarrea con sangre, fiebre, dolor abdominal, náusea, Vómito, desequilibrio Hidroelectrolítico (variable)	Panel de estudios moleculares (Sensibilidad para Salmonella de 79% a 96% y especificidad del 100%). Coprocultivo (Aún se considera el criterio de referencia, ya que su sensibilidad es cercana al 100%), leucocitos en heces	La Salmonella se adhiere a las células epiteliales, llamadas células M (microfold), que se superponen a los parches de Peyer en el colon.	Rehidratación oral o intravenosa. Trimetoprim/sulfametoxazol 800/160 mg; ciprofloxacino 500 mg dos veces al día durante cinco a siete días.
Campylobacter sp	Consumo de pollo mal cocido, adquirido en la comunidad	2 a 5 días.	Diarrea con sangre, fiebre, dolor abdominal, náusea, Vómito, desequilibrio Hidroelectrolítico (variable)	Coprocultivos y prueba de PCR, leucocitos en heces	Se adhiere a las células intestinales dañándolas y produciendo toxinas como la citoquímica o la enterotoxina que producen una respuesta inflamatoria.	Rehidratación oral o intravenosa. Trimetoprim/sulfametoxazol 800/160 mg; ciprofloxacino 500 mg dos veces al día durante cinco a siete días.
Shigella sp.	Persona a persona, adquirida en la comunidad	1 o 2 días.	Diarrea con sangre y moco, fiebre, dolor abdominal, náusea, Vómito, desequilibrio Hidroelectrolítico (variable)	Prueba de PCR (alta sensibilidad (93% a 97%) y especificidad (98% a 100%)) y coprocultivos, leucocitos en heces	Infecta a la célula lo que activa el proceso de apoptosis, esto produce una respuesta intestinal en la mucosa.	Rehidratación oral o intravenosa. Ciprofloxacino, 500 mg dos veces al día. Tratamiento de uno a tres días. Alternativa: trimetoprim/sulfametoxazol 800/160 mg dos veces al día

C. difficile	Infección nosocomial; adquirida en la comunidad	5 a 10 días.	Diarrea con sangre, fiebre, dolor abdominal, desequilibrio electrolítico	Prueba de PCR, coprocultivos, leucocitos en heces	Infecta a la célula con toxinas, esto produce una respuesta intestinal en la mucosa.	Rehidratación oral o intravenosa. Metronidazol, 250 mg cuatro veces al día, hasta 500 mg tres veces al día durante diez días.
Vibrio sp.	Ingesta de mariscos	1 día	Diarrea acuosa con sangre, fiebre, dolor abdominal, náusea, Vómito, desequilibrio Hidroelectrolítico (todo variable)	Se encuentran bacterias Vibrio en las heces, las heridas o la sangre	Infecta a la célula lo que activa el proceso de apoptosis, esto produce una respuesta intestinal en la mucosa.	Rehidratación oral o intravenosa. Dosis única de doxiciclina, 300 mg. Tetraciclinas, 500 mg cuatro veces al día durante tres días. Alternativa: ciprofloxacino, dosis única.
Parasitaria						
Entamoeba histolytica (Amibiasis)	Viajes a regiones tropicales	Dos a cuatro semanas	Diarrea con moco y en ocasiones con sangre, fiebre, dolor abdominal, desequilibrio electrolítico, en ocasiones náusea y vomito	Exámenes coproparasitológicos (si la muestra es líquida, con revisión de moco y sangre), colonoscopia (raspado o biopsia del borde de las úlceras), en ocasiones, leucocitos en heces	Causan necrosis al epitelio intestinal, penetran la mucosa y se dirigen hasta la submucosa donde se extienden en sentido perpendicular respecto de la dirección de su penetración (causan una úlcera).	Rehidratación oral o intravenosa. Metronidazol, 500 mg tres veces al día durante cinco a diez días, más iodoquinol, 650 mg tres veces al día durante diez días.
Giardia sp. (Giardiasis)	Guarderías, asilos, deficiencia de Ig A	12 a 19 días	Diarrea esteatorreicas (grasas) y fétidas. olor abdominal, náuseas y vomito	Quistes, trofozoítos de Giardia en las heces o ambos; trofozoítos en sondeo duodenal, por cápsula de Beal o de biopsia del intestino delgado, coproantígenos y secuencias de ADN.	Inhiben a la tripsina y se protegen con sus VSP, la tiolproteinasa de Giardia hidroliza a las proteínas y rompe las inmunoglobulinas a nivel de la bisagra	Rehidratación oral o intravenosa. Metronidazol, 250 a 500 mg tres veces al día durante siete a diez días.

Fúngica						
Candida albicans	Contacto a través de la piel y las mucosas y por inoculación accidental o mordedura	2 a 12 días	Diarrea, dolor abdominal, flatulencia, distensión abdominal, náuseas y vómitos	Exámenes coproparasitológicos (si la muestra es líquida, con revisión de moco y sangre), colonoscopia	Debido a factores como el desequilibrio del microbiota, el hongo puede proliferar en la mucosa.	Rehidratación oral o intravenosa. Fluconazol, Itraconazol, Nistatina
Cryptococcus	Al inhalar las esporas microscópicas de Aspergillus que se encuentran en el medioambiente.	3-4 días	Diarrea dolor abdominal, náuseas, vomito, distensión abdominal.	Endoscopia (lesiones como nódulos, úlceras y placas)	A medida que el hongo se multiplica y crece en la mucosa intestinal, puede causar daño localizado a las células epiteliales y provocar inflamación en la pared intestinal.	Rehidratación oral o intravenosa. fluconazol, itraconazol y anfotericina B.

Referencias

De Salud, S. (s. f.). 162. Niños y adultos mayores, principales afectados por la parasitosis. gob.mx.

<https://www.gob.mx/salud/prensa/162-ninos-y-adultos-mayores-principales-afectados-por-la-parasitosis>

Enfermedad diarreica aguda bacteriana, Salmonella. (s. f.). http://synapticpg.com/dinf_bac_salm_fisiop.html

Hamilton K.W. (2021). Infecciones por shigella. Stern S.C., & Cifu A.S., & Altkorn D(Eds.), Diagnóstico basado en los síntomas: Una guía basada en evidencias, 4e. McGraw Hill.

<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3069§ionid=259351580>

Hamilton K.W. (2021). Gastroenteritis causada por bacterias del género salmonella. Stern S.C., & Cifu A.S., & Altkorn D(Eds.), Diagnóstico basado en los síntomas: Una guía basada en evidencias, 4e. McGraw

Hill. <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3069§ionid=259351535>

Hamilton K.W. (2021). Infecciones por shigella. Stern S.C., & Cifu A.S., & Altkorn D(Eds.), Diagnóstico basado en los síntomas: Una guía basada en evidencias, 4e. McGraw

Hill. <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3069§ionid=259351580>

Macotela M, & Martínez Gordillo M (2023). Giardiasis. Becerril Flores M.A.(Ed.), Parasitología Médica, 6e. McGraw

Hill. <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3370§ionid=279361196>

Molina Trinidad E, & Díaz Quiñonez J, & Becerril Flores M.A. (2023). Amibiasis. Becerril Flores M.A.(Ed.), Parasitología Médica, 6e.

McGraw Hill. <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3370§ionid=279394641>

Prevención, diagnóstico y tratamiento de diarrea aguda en adultos en el primer nivel de atención, México: Secretaría de Salud, 2008.

Secretaría de Salud. (2015). ¿Qué es el Rotavirus? [https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-el-](https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-el-rotavirus#:~:text=Es%20un%20virus%20que%20provoca,a%2024%20meses%20de%20edad.&text=Una%20medida%20de%20prevenci%C3%B3n%20contra,del%20Esquema%20Nacional%20de%20Vacunaci%C3%B3n)

[rotavirus#:~:text=Es%20un%20virus%20que%20provoca,a%2024%20meses%20de%20edad.&text=Una%20medida%20de%20prevenci%C3%B3n%20contra,del%20Esquema%20Nacional%20de%20Vacunaci%C3%B3n](https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-el-rotavirus#:~:text=Es%20un%20virus%20que%20provoca,a%2024%20meses%20de%20edad.&text=Una%20medida%20de%20prevenci%C3%B3n%20contra,del%20Esquema%20Nacional%20de%20Vacunaci%C3%B3n).

Virus de las diarreas. Ryan K.J.(Ed.), (2022). Sherris & Ryan. Microbiología Médica, 8e. McGraw

Hill. <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3217§ionid=268105359>